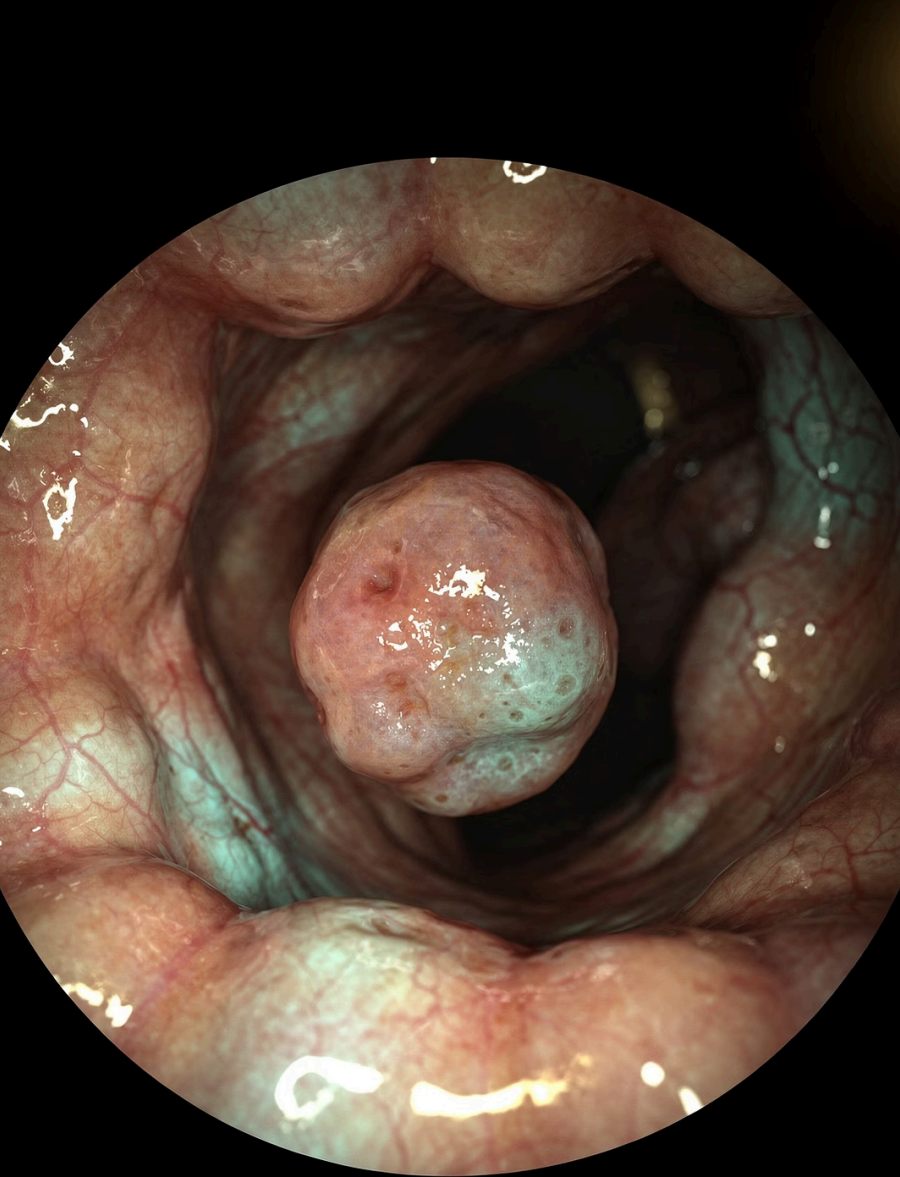


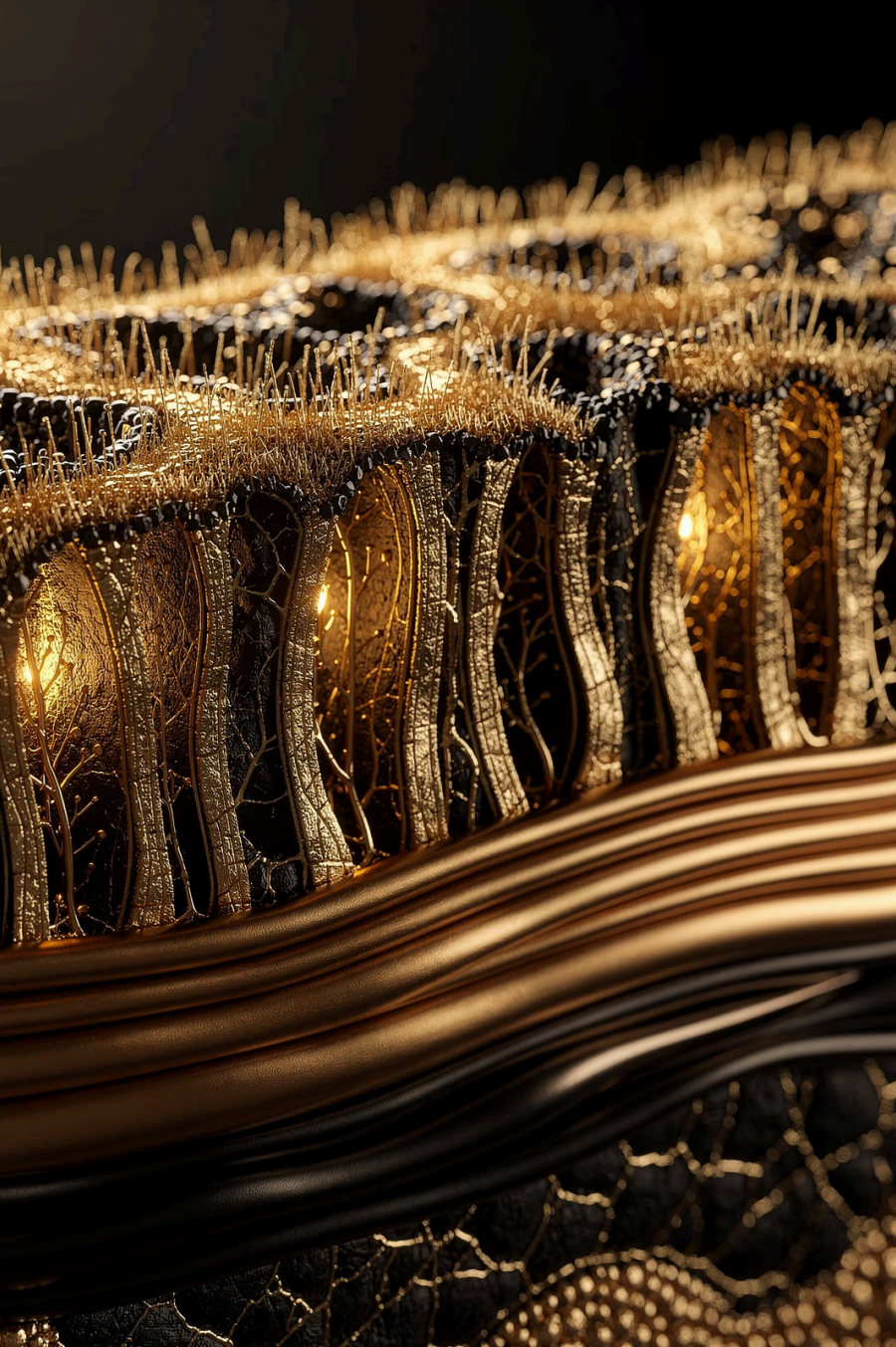


Classificação JNET em Tumores Colorretais

Diagnóstico óptico baseado em padrões vasculares e de superfície

ENDOSCOPIA AVANÇADA

DIAGNÓSTICO ÓPTICO



O que é a Classificação JNET?

Origem

Classificação japonesa padronizada, desenvolvida por especialistas em endoscopia digestiva para diagnóstico óptico em tempo real

Baseada em dois pilares



Padrão Vascular

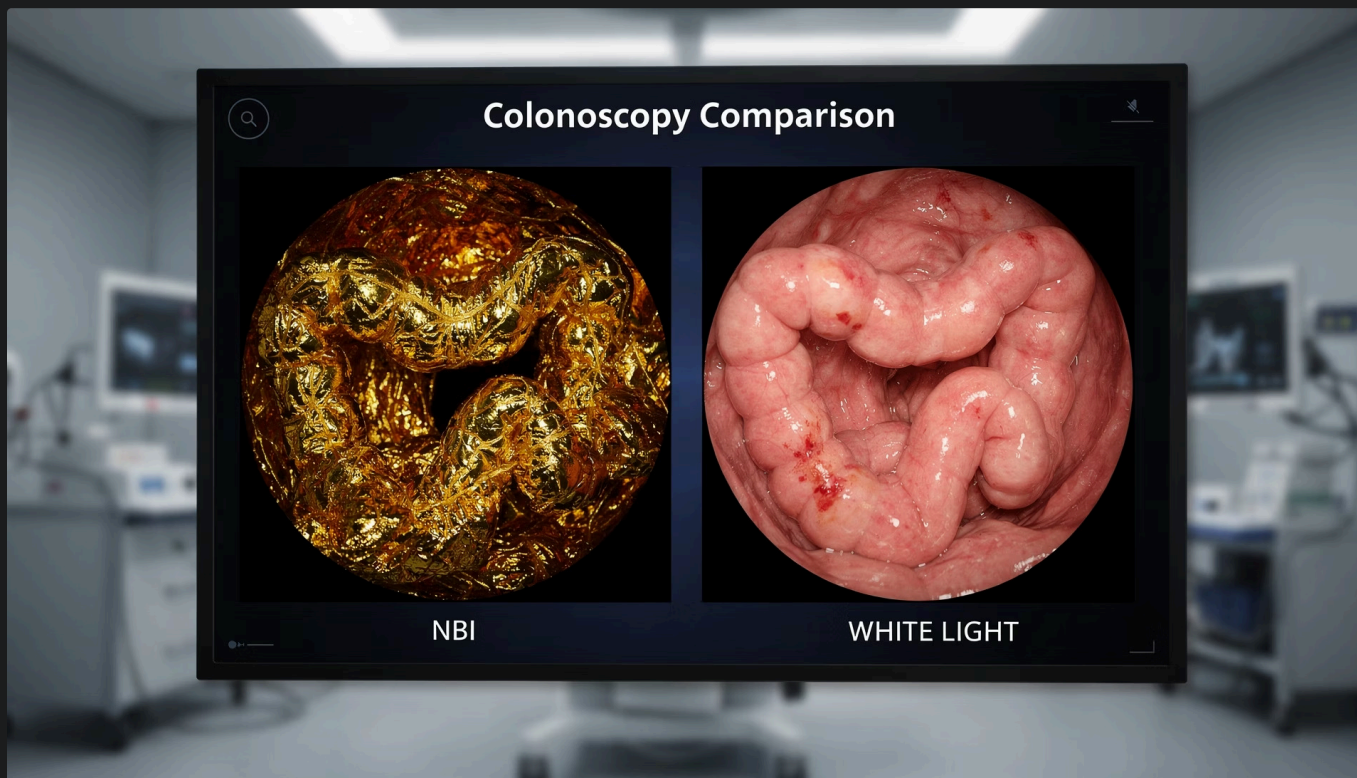
Microvasculatura da lesão



Padrão de Superfície

Arquitetura das criptas

Princípio da Classificação



Tecnologia aplicada

- **NBI + Magnificação**
Realce de microvasculatura e superfície mucosa
- **Avaliação em Tempo Real**
Predição histológica sem biópsia imediata
- **Decisão Imediata**
Conduta definida durante o exame

Visão Geral da Classificação JNET

Quatro tipos com correlação histológica direta

1

Tipo 1

Não neoplásico

2

Tipo 2A

Baixo grau

3

Tipo 2B

Alto risco

4

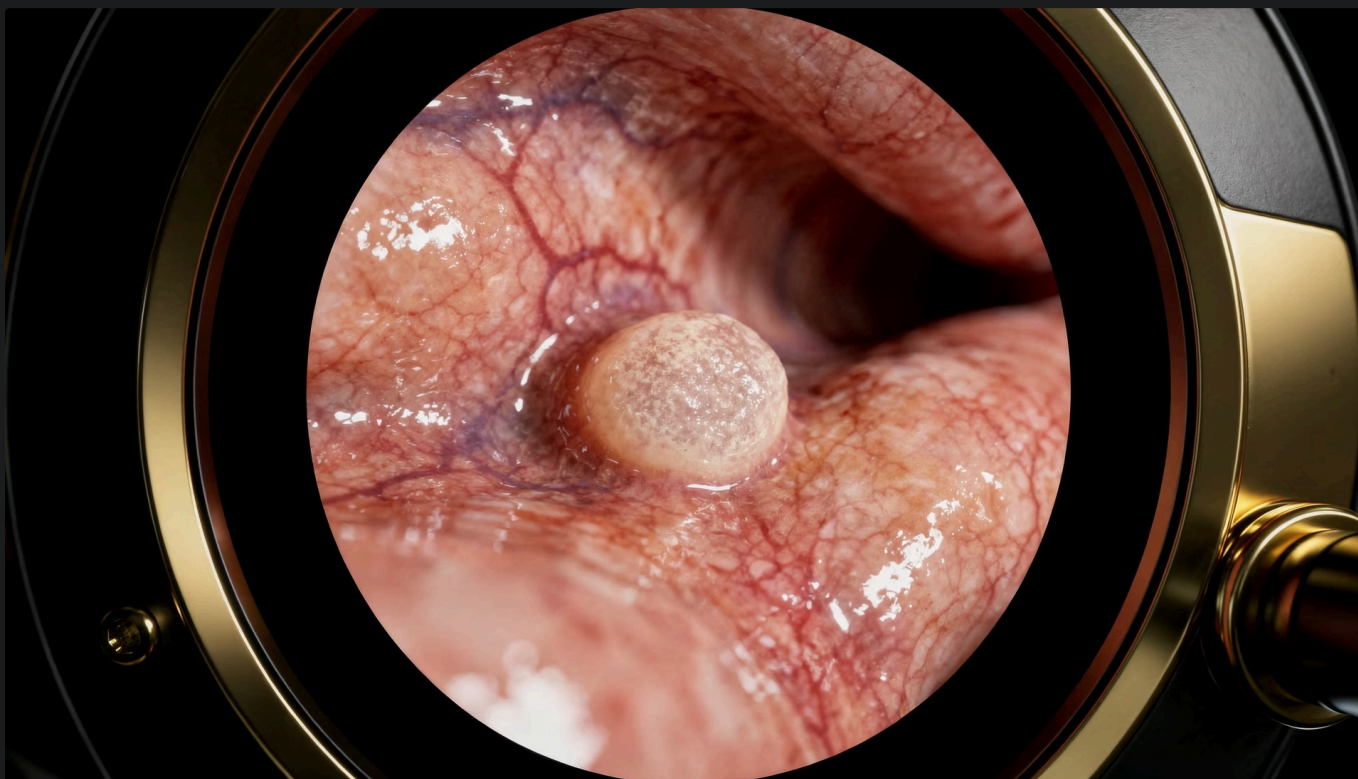
Tipo 3

Invasivo

Progressão de risco crescente — da lesão benigna ao carcinoma invasivo profundo

TIPO 1

Tipo 1 — Não Neoplásico



🔴 Padrão Vascular

Invisível ou semelhante à mucosa normal

▣ Padrão de Superfície

Regular — pontos claros ou escuros uniformes

🧬 Histologia

Pólipos hiperplásicos e lesões serrilhadas sessas

TIPO 2A

Tipo 2A — Adenoma de Baixo Grau



🔴 Padrão Vascular

Regular, calibre homogêneo,
distribuição uniforme

▣ Padrão de Superfície

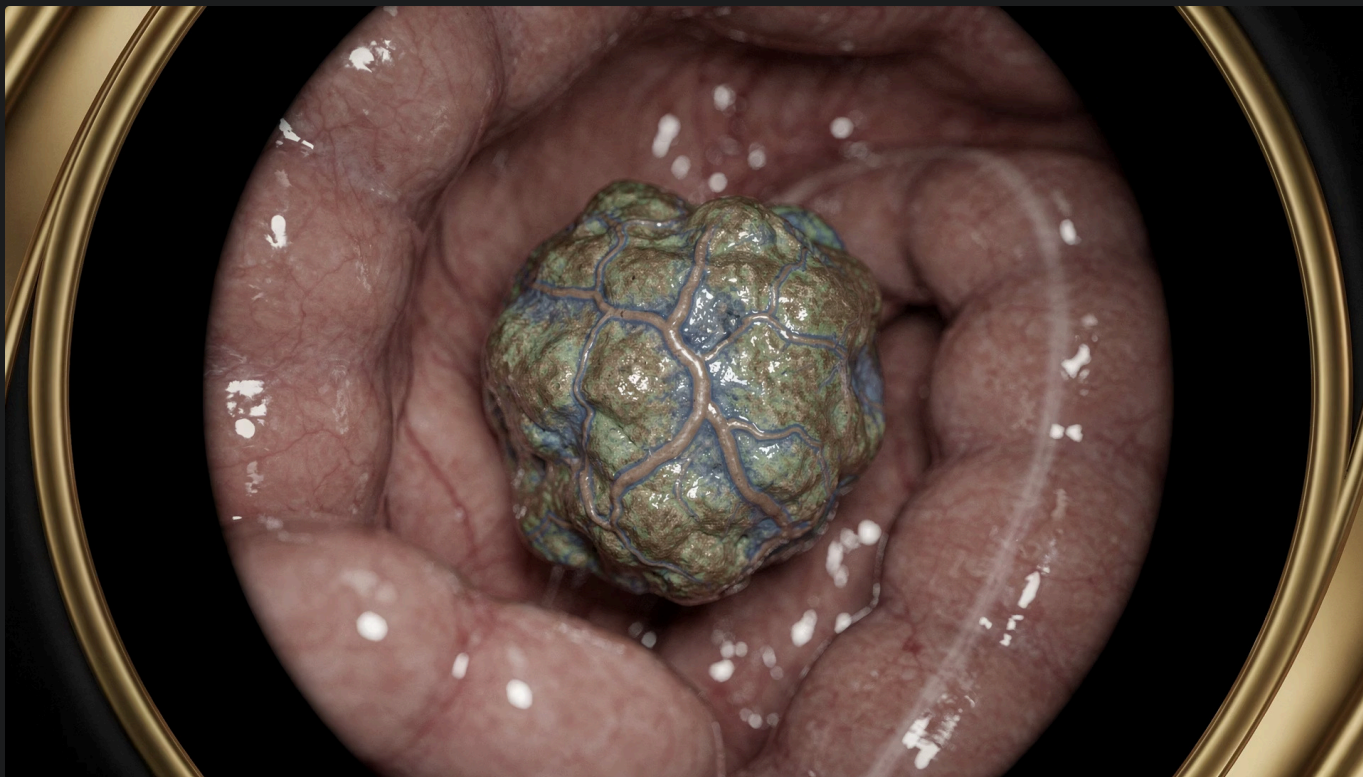
Tubular ou ramificado, bem definido

🧬 Histologia

Adenoma tubular ou tubuloviloso
de baixo grau

TIPO 2B

Tipo 2B — Alto Risco



Vascular

Irregular, calibre variável, distribuição heterogênea

Superfície

Irregular ou pouco definida

Histologia

Displasia de alto grau ou Ca com invasão superficial (SM1)

TIPO 2B

SUBCLASSIFICAÇÃO

Subclassificação do Tipo 2B

2B Low

- Vasos irregulares, porém ainda organizados
- Criptas preservadas
- Baixo risco de invasão profunda
- → Candidato a ressecção endoscópica avançada

2B High

- Vasos completamente desorganizados
- Criptas destruídas ou ausentes
- Alto risco de invasão profunda (SM2/SM3)
- → Considerar cirurgia

❏ A distinção 2B Low vs High é a zona cinzenta mais desafiadora da classificação JNET

TIPO 3

Tipo 3 — Carcinoma Invasivo



🔴 Padrão Vascular

Áreas avasculares — vasos interrompidos ou ausentes

▣ Padrão de Superfície

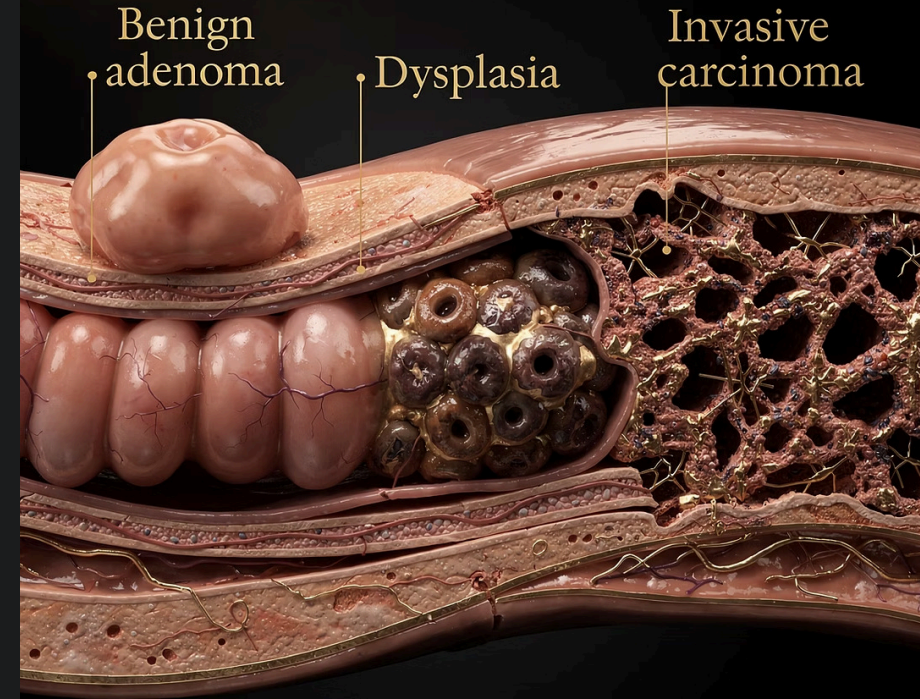
Amorfo — perda completa do padrão de criptas

🧬 Histologia

Carcinoma com invasão profunda (SM2/SM3 ou além)

Progressão Adenoma → Carcinoma

- Tipo 1
Mucosa normal / hiperplásica
- Tipo 2A
Adenoma baixo grau
- Tipo 2B
Displasia alto grau / SM1
- Tipo 3
Carcinoma invasivo profundo



Importância Clínica



Por que o JNET transforma a prática?

Decisão imediata

Conduta definida durante o exame, sem aguardar biópsia

Triagem cirúrgica

Define ressecção endoscópica vs encaminhamento cirúrgico

Menos biópsia

Reduz procedimentos desnecessários e tempo do exame

Conduta Baseada no JNET



Tipo 1

Tipo 2A

Tipo 2B

Tipo 3

O diagnóstico óptico pelo JNET determina diretamente a estratégia terapêutica — do acompanhamento clínico à cirurgia.

Limitações da Classificação

**DEPENDÊNCIA
DO OPERADOR:**
**Experiência
requerida**

**SOBREPOSIÇÃO
ENTRE TIPOS:**
**Padrões
intermediários**

ZONA CINZENTA
**2B: Difícil
distinção**
Low vs High



Pontos de atenção

O JNET é poderoso, mas seu desempenho diagnóstico é diretamente proporcional à experiência do endoscopista e à qualidade do equipamento (NBI + magnificação de alta resolução).

- ❑ A sensibilidade para Tipo 3 é alta, mas a especificidade para 2B ainda apresenta variabilidade interobservador na literatura



Take Home Message



Ferramenta essencial

JNET é padrão-ouro para diagnóstico óptico de lesões colorretais



Dois pilares

Padrão vascular + padrão de superfície sob NBI e magnificação



Tempo real

Diagnóstico e conduta definidos durante o exame



Impacto direto

Do acompanhamento à cirurgia — cada tipo tem sua conduta